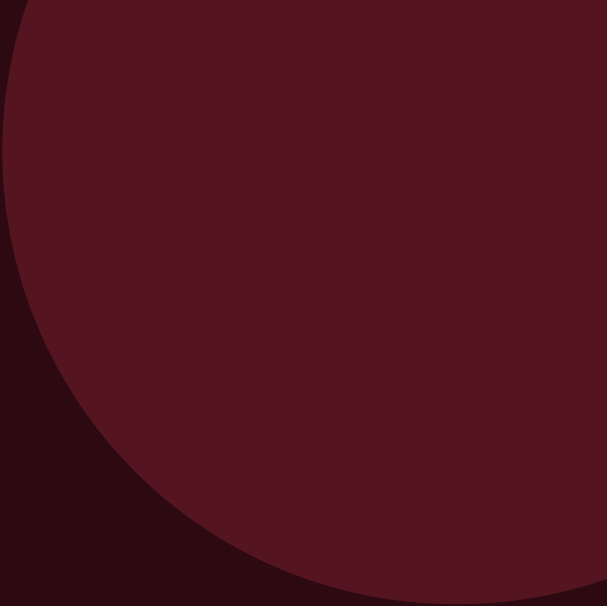




DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 04 DE 12

Estrutura do tratamento

A DBT trabalha por princípios e tem estrutura definida. Estágios, hierarquia de alvos e as cinco funções são o que organiza a sessão e a formulação do caso.

ENCONTRO DE SÁBADO, 5 DE SETEMBRO DE 2026 · 10H ÀS 12H
CONDUZIDO POR ANDRESSA JULIANA

DESCOMPLICANDO A DBT

Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

Júlio Gonçalves



IDEALIZADORA · PROFESSORA

Andressa Juliana

Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

O ESSENCIAL

- **Meta de vida é o que o paciente quer. Alvo de tratamento é a pedra no caminho.** Cabe ao terapeuta identificar as pedras.
- **A hierarquia de alvos organiza a sessão:** risco de vida, depois o que interfere na terapia, depois o que corrói a qualidade de vida.
- **O cartão diário abre a sessão.** Ele mostra a semana e define sobre o que se vai falar.
- **O que define a DBT abrangente são as cinco funções, não os modos.** As funções podem ser cumpridas de formas diferentes.

01 Metas de vida e alvos de tratamento

São coisas diferentes e a confusão entre elas atrapalha a formulação. A meta de vida é o que o paciente quer alcançar, com diagnóstico ou sem nenhum: terminar a faculdade, ter uma relação estável, voltar a trabalhar. O alvo de tratamento é o que está no meio do caminho.

O paciente costuma trazer a meta. Quem nomeia os alvos é o terapeuta, a partir do que observa.

02 A casa: pré-tratamento e os quatro estágios

A DBT trabalha por princípios e tem estrutura definida. A imagem usada em aula foi a de uma casa, onde cada andar depende do anterior.



A estrutura do tratamento em estágios, com o pré-tratamento como porta de entrada.

No estágio 1 o trabalho é tirar o paciente do descontrole comportamental e ensinar habilidades. No estágio 2 entram trauma, vergonha e autovalidação, com histórias de negligência, abuso sexual ou agressão física. Os estágios 3 e 4 tratam de problemas da vida cotidiana, sentido e vazio existencial. Há pouco material clínico sobre eles, porque muitos pacientes que chegam ali migram para outra abordagem ou encerram o processo.

03 A hierarquia de alvos

Ela existe para decidir sobre o que falar quando a semana trouxe cinco assuntos. A ordem não muda.



Sem segurança e sem terapia acontecendo, não há progresso possível nos outros níveis.

A hierarquia não é fixa

Um comportamento troca de nível conforme a função muda. O uso de substâncias entra como qualidade de vida, mas sobe para risco de vida se a pessoa passa a usar como

método letal, ou se o uso inviabiliza a terapia.

04 Risco de vida: gravidade e iminência

Diante de risco, duas perguntas orientam a conduta. A gravidade diz respeito ao método e ao risco médico real. A iminência diz respeito à probabilidade de acontecer agora. Foram citados instrumentos de avaliação e o trabalho de Botega como recurso de monitoramento em períodos de crise ou de mudança na vida do paciente.

A ideação suicida crônica recebeu tratamento à parte. Ela pode funcionar como estratégia de regulação emocional, e nesse caso não exige interromper todo o plano terapêutico. O que decide é a análise em cadeia: entender a função daquele comportamento antes de reagir a ele.

O mesmo raciocínio vale para a autolesão. Tecnicamente é comportamento de risco, mas a avaliação é individual, por função e gravidade. Nem toda autolesão ameaça a vida de imediato.

05 O que interfere na terapia

Faltas, não pagamento, recusa de colaborar, descumprir o combinado sobre o contato entre sessões. Dentro desse nível existe uma prioridade máxima: o que pode encerrar o tratamento. Não pagamento, faltas recorrentes e rupturas graves na aliança precisam ser tratados na hora em que aparecem.

INCLUI O COMPORTAMENTO DO TERAPEUTA

Responder mensagens em excesso reforça padrões desadaptativos e leva ao esgotamento.
Monitorar o próprio comportamento faz parte do nível 2 da hierarquia.

06 Qualidade de vida

Uso de substâncias, dinheiro, moradia, relações disfuncionais. A priorização dentro desse nível segue duas perguntas: o que está causando crise imediata e o que sustenta funcionalmente os comportamentos de maior risco. O uso que leva à ideação é o exemplo direto disso.

07 O cartão diário

É a ferramenta central do estágio 1 e a primeira etapa de cada sessão individual. Ele registra comportamentos-alvo, uso de medicação, sono, dor física, emoções e habilidades usadas. A revisão do cartão orienta a conversa e garante que a hierarquia seja respeitada.

- **Papel ou digital, tanto faz.** Foram mostrados vários modelos, incluindo formulários curtos disparados por aplicativo de mensagem.
- **Serve para além da DBT.** O automonitoramento se adapta a outras demandas clínicas. O ganho é o paciente aprender a se perceber e identificar padrões.
- **Se o paciente não preenche, preencha na sessão.** Isso modela o comportamento e permite analisar a semana.
- **Falha repetida vira alvo.** Uma breve análise em cadeia ou de soluções, validando a dificuldade. Se o impedimento for excesso de campos, simplifique a ferramenta.

Vale incluir a percepção do próprio paciente sobre a confiança dele em controlar as emoções, antes e depois da sessão. Funciona inclusive com pacientes internados, com acesso limitado a tecnologia.

08 Os modos e as cinco funções

O ponto que a aula sublinhou: ao avaliar um caso para DBT abrangente, olhe as funções, não os modos. A mesma função pode ser cumprida de maneiras diferentes.

FUNÇÃO	MODO QUE COSTUMA CUMPRIR
Aumentar a motivação trabalhar o que impede a mudança	coordena o caso e guia os outros modos
Aumentar capacidades aquisição de habilidades novas	Treinamento de habilidades ciclos de 6 a 8 meses, encontros semanais de 1h30 a 2h
Generalizar para a vida usar a habilidade onde ela é necessária	no momento da crise, com regras combinadas antes
Sustentar o terapeuta efetividade e motivação de quem atende	Consultoria de equipe de 3 a 9 terapeutas, encontros semanais ou quinzenais
Estruturar o ambiente quando o ambiente supera a capacidade do paciente	com cautela na comunicação com familiares e psiquiatra

As cinco funções e os modos correspondentes. A DBT abrangente cumpre as cinco.

Na consultoria de equipe vale um acordo que muda a prática: o paciente de um membro é paciente de todos. Isso permite cobertura de coaching durante férias ou crises.

O treinamento de habilidades funciona melhor em grupo, pela validação social. O formato individual é alternativa viável para quem tem dificuldade em grupos, horário incompatível ou necessidade específica de aprendizagem, e deve ser conduzido por outro terapeuta.

09 Coaching telefônico: as regras vêm antes

A função é generalizar habilidades e resolver crises interpessoais. Quem atende é o terapeuta individual ou, temporariamente, alguém da equipe.

O alerta mais forte da aula foi sobre limites. Sem regras combinadas no início, o contato reforça busca de proximidade. Quando o terapeuta tenta impor o limite depois, sem acordo prévio, a aliança racha.

Quando o uso vira excesso

Avalie a função do comportamento, que costuma estar ligada à solidão ou ao medo do abandono. A conduta sugerida foi não responder a mensagens que não envolvam uso de habilidades ou plano de crise, e retomar o limite na sessão seguinte com análise em cadeia. O suporte existe para aplicar habilidade, não para garantir disponibilidade emocional.

10 Manejo de caso

Intervir no ambiente só quando ele supera a capacidade do paciente de mudar a si mesmo. A comunicação com familiares e psiquiatras pede cautela: contato direto e escondido rompe vínculo e alimenta triangulação. O paciente fica no centro da comunicação.

11 Abrangente ou adaptada

A DBT abrangente cumpre as cinco funções. A adaptada não cumpre todas. Duas consequências foram nomeadas em aula: a adaptada tem menos suporte de evidência e aumenta a responsabilidade legal do terapeuta em casos de risco.

A saída dialética é buscar a síntese possível dentro das limitações do contexto real, sem perder de vista que a abrangente é o modelo de referência.

12 Levar para a prática

MATERIAIS COMBINADOS

Ficaram de ser disponibilizados: gravação da aula, slides, indicações de leitura, modelos de formulação de caso e todos os modelos de cartão diário mostrados. Também ficou o contato de locais que oferecem grupo de treinamento de habilidades, para quem pedir. As formulações podem ser enviadas para revisão individual.

14 Referências

Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press. — estágios, alvos e estrutura do tratamento.

Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2ª ed.). Guilford Press. — formato e condução do treinamento de habilidades.

Botega, N. J. (2015). *Crise suicida: avaliação e manejo*. Porto Alegre: Artmed.

Bohus, M., Kleindienst, N., Hahn, C., et al. (2020). DBT-PTSD compared with cognitive processing therapy in complex presentations of PTSD in women survivors of childhood abuse. *JAMA Psychiatry*, 77(12), 1235–1245.

NOTA DE MÉTODO

Resumo escrito a partir das anotações automáticas do encontro, que sintetizam a discussão em tópicos. Participantes não são identificados. Três pontos ficaram sem confirmação e aparecem aqui de forma genérica: o nome de uma das escalas de avaliação de risco citadas em aula, que a transcrição registra de modo incerto; o nome da plataforma usada para disparar formulários de automonitoramento por aplicativo de mensagem, que na transcrição aparece trocado com o da plataforma do curso; e a referência bibliográfica do protocolo DBT-PE, de Melanie Harned, citado em aula sem dados completos. O livro de Botega e o ensaio de Bohus foram conferidos nas fontes originais. Os diagramas desta página foram desenhados a partir do conteúdo da aula.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

- ☐ Preenchi na formulação o estágio atual do paciente e justifiquei por que ele está ali.
- ☐ Listei os alvos, separando comportamentos a aumentar e a diminuir.
- ☐ Registrei no estágio 1 os comportamentos que ameaçam a vida e os que interferem na terapia.
- ☐ Descrevi quais funções do tratamento estão sendo cumpridas hoje e como.
- ☐ Comuniquei ao paciente as regras do coaching telefônico, com horários e limites.

Minhas anotações — o que levo para a clínica

Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

01. Qual a diferença entre meta de vida e alvo de tratamento? Escreva a meta e dois alvos do paciente que você acompanha nas 12 aulas.

02. Um paciente usa álcool com frequência. Em que situação esse comportamento sobe de nível na hierarquia de alvos?

03. Por que as regras do coaching telefônico precisam ser combinadas antes do primeiro contato?

04. No seu contexto de trabalho, quais das cinco funções estão sendo cumpridas hoje e quais não estão?